



Université
d'Alger

Cariologie : Terminologie, Étiopathogénie & Données Épidémiologiques

L'Essentiel pour la 2ème Année

Université d'Alger - Faculté de Médecine
Service d'Odontologie Conservatrice
Dr Djoudi.Z

La Carie Dentaire : Un Fléau Mondial

La carie dentaire est la pathologie la plus répandue dans le monde, touchant la quasi-totalité des individus.

Classée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au 3ème rang des fléaux mondiaux, après les affections cancéreuses et les maladies cardiovasculaires.



Définition : Les Termes Clés à Maîtriser

Selon l'OMS :

« La carie dentaire est une maladie d'origine polymicrobienne, d'étiologie multifactorielle [Q1] aboutissant à une dissolution des tissus dentaires dans les fluides de la cavité buccale. »

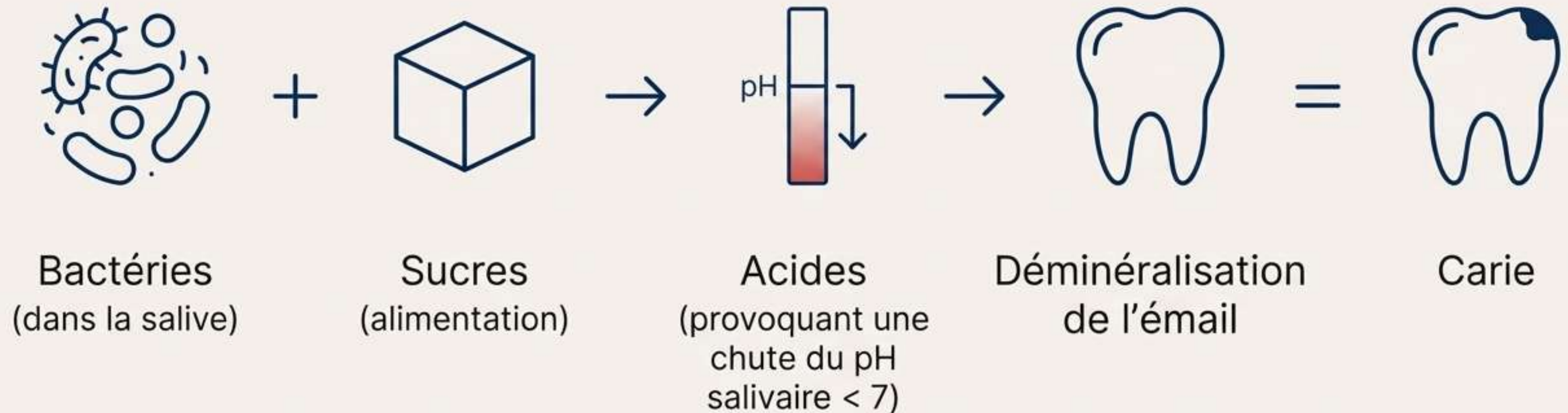


Caractéristiques essentielles :

- C'est un processus dynamique [Q1].
- C'est une maladie transmissible [Q1].

Le Mécanisme du Processus Carieux : Une Réaction en Chaîne

Le processus carieux est une cascade d'événements :

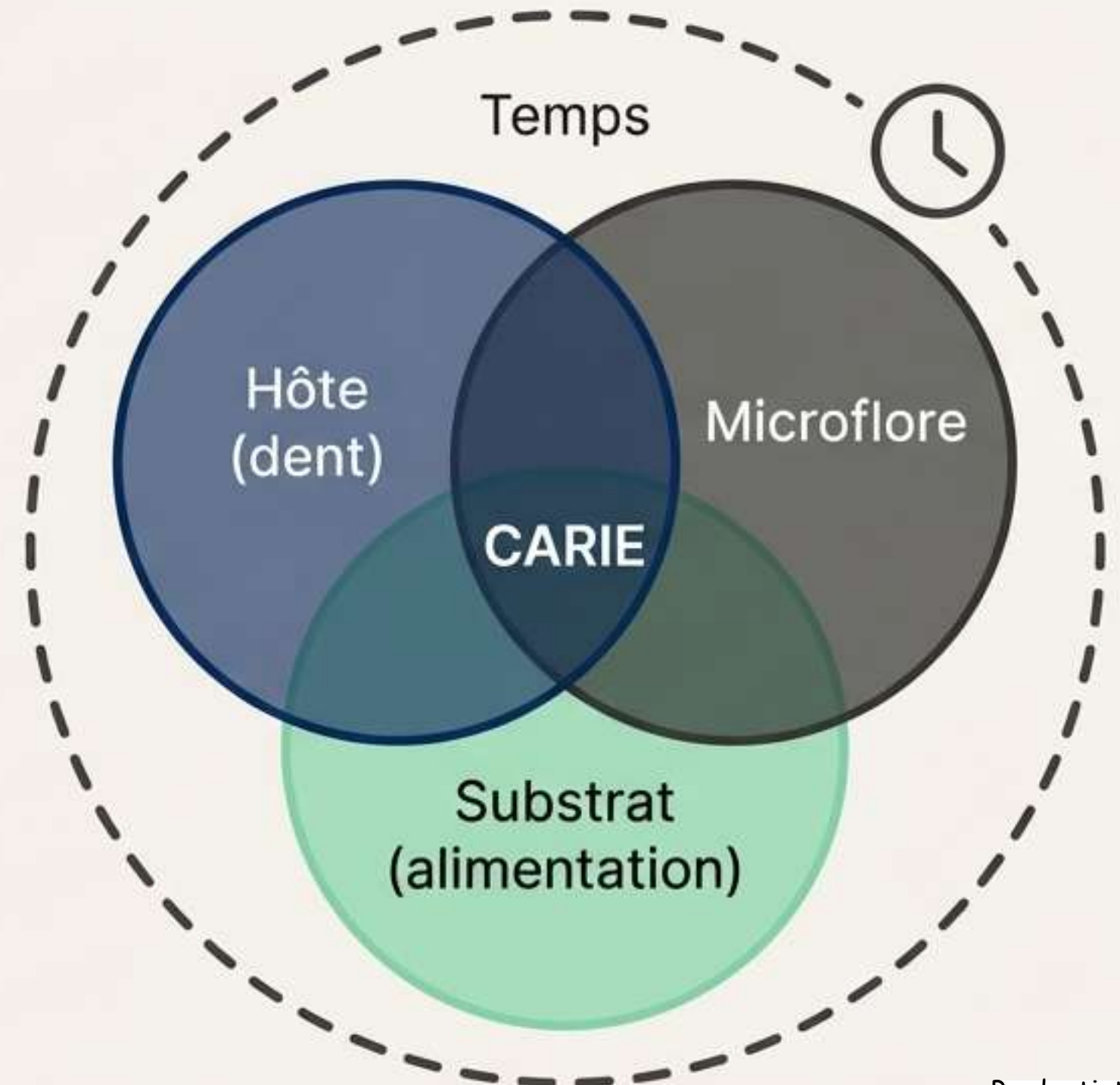


Étiopathogénie : La Recette de la Carie

En 1962, Keyes a schématisé la relation entre les trois facteurs de risque principaux.

La trilogie de Keyes : la carie se développe à l'intersection de trois facteurs : Hôte (dent) + Microflore + Substrat (alimentation) [Q5].

KÖNIG ajoute un quatrième facteur
KÖNIG ajoute un quatrième facteur
essentiel : le Temps [Q5], nécessaire au développement de la lésion.



Formes Cliniques (1/2) : Classification par Tissu et Évolution

Selon la Localisation Tissulaire

- **Carie de l'émail:** Lésion initiale, asymptomatique [Q18] (parfois appelée 'white spot'), montrant une simple rugosité.
- **Carie de la dentine:** Se présente comme un cône carieux dont la base est à la jonction émail-dentine.



- **Carie du cément:** Apparaît suite à des récessions gingivales, plus fréquente chez le sujet âgé.



Selon l'Évolution

- **Carie arrêtée :** Lésion stationnaire. Signe pathognomonique : fond dentinaire noir et brillant [Q16]



- **Carie à évolution lente:** Lésion chronique et indolore. La dentinogenèse réactionnelle stabilise son évolution [Q17].
- **Carie à évolution rapide:** Lésion douloureuse, la dentinogenèse est dépassée, évoluant rapidement vers l'inflammation pulpaire.

Formes Cliniques (2/2) : La Classification SiSta (Mount & Hume)

Une **classification à but thérapeutique** [Q3] qui croise le site de la lésion et son stade évolutif (taille) pour guider le traitement.

Les 3 Sites

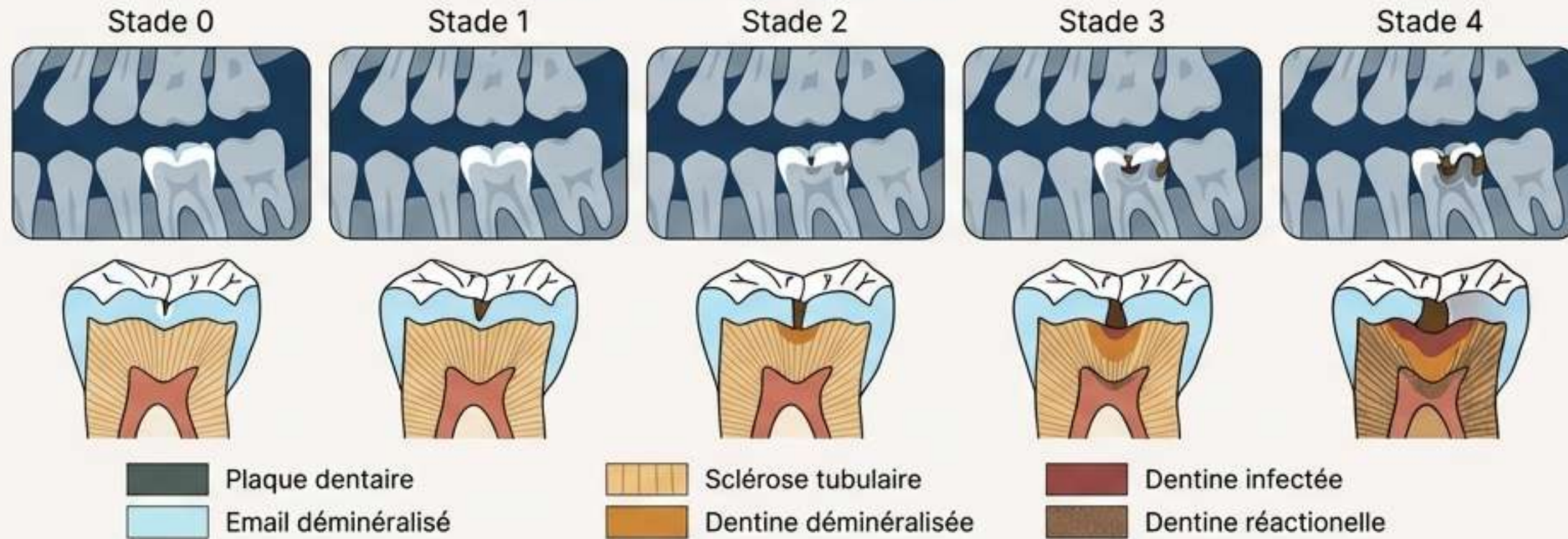
Site 1	Site 2	Site 3
Puits, sillons et fosses (surfaces occlusales) [Q4]	Faces proximales (points de contact) [Q3]	Tiers cervical des couronnes (émail ou ciment) [Q3]

Les 5 Stades (Taille)

- **Stade 0** : Lésion initiale, non cavitaire.
- **Stade 1** : Microcavitation de surface (atteint le tiers externe de la dentine).
- **Stade 2** : Cavité de taille moyenne (atteint le tiers médian de la dentine).
- **Stade 3** : Cavité importante atteignant le tiers profond de la dentine, pouvant fragiliser les cuspides [Q4].
- **Stade 4** : Cavité très étendue atteignant la zone parapulpaire.

Visualisation de la Classification SiSta

Visualisation des Stades



Visualisation des Sites



Épidémiologie : Mesurer l'Impact de la Carie

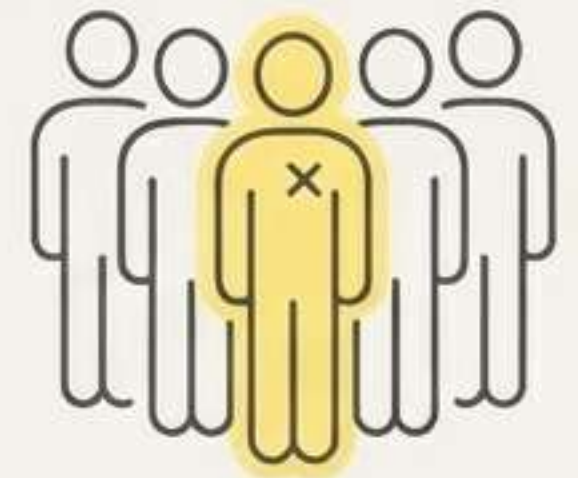


Épidémiologie

L'étude de la fréquence et de la répartition des maladies dans le temps et l'espace, ainsi que les facteurs qui les déterminent au sein d'une population.

Prévalence

Le nombre de cas d'une maladie rapporté à la population générale à un moment donné.



Les Indices Carieux : Le Langage Standard de l'Épidémiologie

En Denture Permanente

CAOD (ou DMF-T)

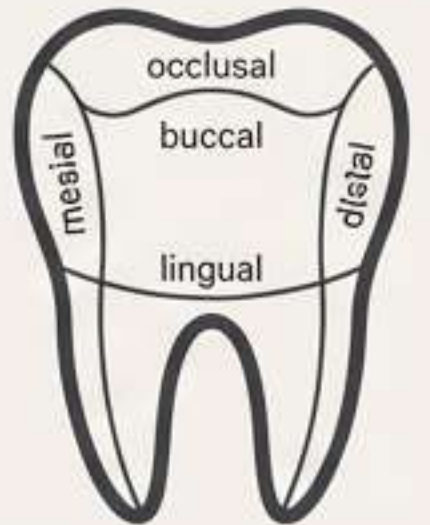


C'est la somme du nombre de dents Cariées, Absentes (pour cause de carie), et Obturées.

Il varie de 0 à 32 [Q2].

CAOF (ou DMF-S)

C'est la somme du nombre de faces Cariées, Absentes, et Obturées. L'indice peut varier jusqu'à 128 (4 faces/ant., 5/post.) ou 148 (si les 3èmes molaires sont incluses).



En Denture Temporaire : Les indices équivalents sont notés en minuscules : **caod** (ou def-t) et **caof** (ou def-s).

L'Évaluation du Risque Carieux Individuel (RCI)

Objectif : Détecter les individus hautement susceptibles de développer des lésions pour cibler les mesures préventives et déterminer l'approche thérapeutique (non-invasive vs. restauratrice).

Faible

Moyenne

Élevée



Atteinte des faces
occlusales uniquement.

Atteinte des faces occlusales
ET des faces proximales des
dents postérieures.

Atteinte des faces
occlusales ET des dents
antérieures.

Situation Épidémiologique : Monde vs. Algérie



Dans le Monde

Réduction significative des indices **carieux** (de 10 à 70%) dans les **pays industrialisés** depuis les années 70-80, principalement grâce à l'introduction du **fluor**.

Exemples d'indices CAOD à 12 ans :
Suisse (1.6), Danemark (1.7), Allemagne (5.2).



En Algérie

La carie dentaire est la pathologie **la plus** fréquente en milieu scolaire.

La prévalence est estimée entre **37% et 40%**.

Constat d'une grande carence dans la **prise en charge** et l'absence d'une stratégie de lutte nationale.

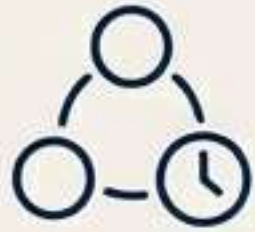
Synthèse : Les Points Clés à Retenir



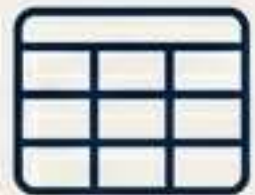
La carie est une maladie **multifactorielle** et un processus **dynamique**.



Le mécanisme est une **déminéralisation acide** provoquée par le métabolisme des sucres par les bactéries.



La **Trilogie de Keyes + le Temps** sont les 4 facteurs étiologiques fondamentaux.



La classification **SiSta** (Site / Stade) est l'approche moderne indispensable pour guider la thérapeutique.



Les indices **CAOD** et **CAOF** sont les outils standards pour mesurer la prévalence de la carie en épidémiologie.

Annexe : Glossaire

Pathognomonique

Se dit d'un signe clinique qui, à lui seul, permet d'établir un diagnostic certain. (Ex: le fond noir et brillant de la carie arrêtée).

Dentinogenèse

Processus de formation de la dentine par les odontoblastes. La dentine réactionnelle est celle formée en réponse à une agression comme la carie.

Prophylaxie

Ensemble des moyens médicaux mis en œuvre pour empêcher l'apparition, l'aggravation ou l'extension des maladies. (Ex: cario-prophylaxie par le fluor).